ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-RIOHACHA EN COLOMBIA

DAYANA ALEJANDRA RINCÓN PARDO

DIEGO ALEJANDRO ALZATE RODRÍGUEZ

ANGIE MOLINA VILLAREAL

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

DEMOGRAFÍA

BOGOTÁ

20 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Inicialmente el Departamento de la Guajira, se encuentra en la Región Caribe Colombiana, donde limita con Venezuela, el departamento del Cesar, Magdalena y el Caribe. Cuenta con un área geográfica de 20.842 kilómetros cuadrados y contiene 15 municipios dentro de los cuáles algunos son San Juan, Fonseca, Riohacha, La Jagua etc.

Tabla 1: Indicadores Demográficos para el Departamento de la Guajira

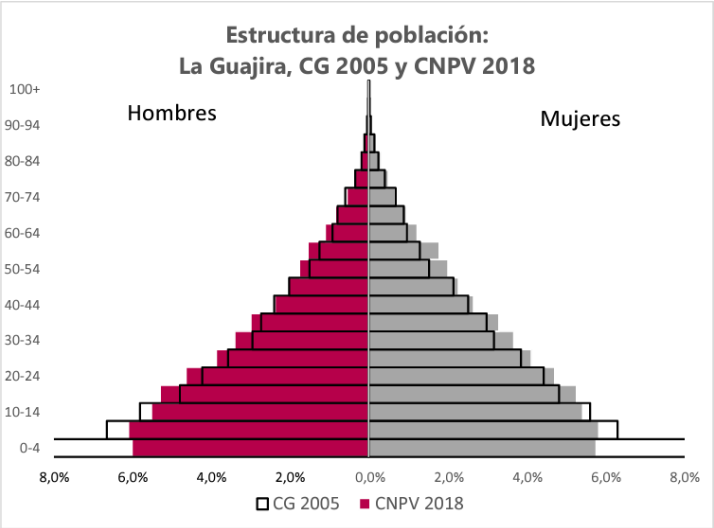
Indicadores Demográficos	La Guajira	
Indicadores Tamaño y Distribución		
Tamaño	825364,00	
Porcentaje Población Urbana	47,48%	
Porcentaje población rural	52,52%	
Densidad población total	39,60	
Densidad población urbana	18,80	
Densidad población rural	20,80	
Indicadores Estructura		
Razón de Sexos	95,98	
Indice de feminización	124,18	
Relación de dependencia	66,26	
Relación de dependencia senil y juvenil	8,60	57,66
Indice de envejecimiento	57,66	
Porcentaje de mayores de 60 años	7,33	
Indice de Sobreenvejecimiento	21,53	

Fuente: Elaboración Propia

Dentro de su caracterización poblacional tenemos que el departamento cuenta con 825364 personas donde el 47.48% pertenecen a población urbana, mientras que el 52.52% pertenece a la población rural, haciendo que el departamento tenga una mayor proporción de individuos en áreas rurales que urbanas, sin embargo no con una diferencia significativamente marcada en estos tipos, por otra parte cuenta con una densidad poblacional de 39.60 individuos por kilómetro cuadrado, donde la densidad poblacional rural es mayor con un nivel de 20.80 individuos en áreas rurales por kilómetro cuadrado.

Este departamento para el año 2018 cuenta con 26 resguardos indígenas de los cuales 8 se encuentran en el municipio de Riohacha, donde según el Informe Socioeconómico de la Guajira (2018) la población indígena representa el 28.9% de la población total del departamento.

Gráfica 1: Pirámide Poblacional la Guajira 2005 y 2018 Colombia



Fuente: DANE Censo Nacional Población 2018, Censo General 2005

A nivel general para el Departamento de la Guajira podemos observar que para el año 2005, existían altas tasas de natalidad y volúmenes de individuos de rango de 0 a 14 años, es decir un gran nivel de población infantil junto a altas tasas de mortalidad en individuos de 80 años o más, este comportamiento poblacional muestra también un aumento lento de la esperanza de vida y una tasa de crecimiento poblacional alta, por otra parte el comportamiento demográfico en hombres y mujeres es similar dado que no se ven grandes disimilitudes entre la población por sexo para distintos rangos de edad.

Ahora para el año 2018, después de 13 años podemos observar comparativamente una contracción de la base de la pirámide y de las poblaciones infantiles de 0 a 14 años, lo que nos sugiere la presencia de una baja tasa de natalidad y además una alta mortalidad infantil, lo cual podemos explicar desde la óptica económica, donde tenemos según el Informe Sociodemográfico de la Guajira (2018) el departamento presenta que el 52.6% de la población se encuentra en condiciones de pobreza monetaria, donde definimos que la pobreza es la incapacidad que tiene un individuo para satisfacer sus necesidades básicas vitales, es decir la privación severa de las necesidades humanas según las Naciones Unidas , la metodología usada por el DANE para la medición de la pobreza se basa en la definición de un umbral, llamado línea de pobreza que representa el valor en pesos colombianos de la canasta básica para un individuo, el umbral de pobreza para el año 2018 fue de $224.338 pesos por ende tenemos que el 52.6% de la población del departamento tenía un ingreso per cápita inferior a

$224.338 pesos mensuales, por otra parte la población en situación de pobreza extrema fue del 7.4%, en ese orden de ideas tenemos que el DANE para ese año define la línea de pobreza extrema en $110.835 pesos mensuales., donde la línea de pobreza extrema se define como las necesidades calóricas mínimas para garantizar la supervivencia de un individuo.

De tal manera en base a lo anterior con una población donde más de la mitad de los individuos son pobres y 7.4 de cada 100 personas viven en situación de extrema pobreza. Para la incidencia y severidad de la pobreza que nos indican que tan lejos está un individuo de la línea de pobreza, tenemos que el departamento de la guajira tiene un nivel 5,7% de severidad de la pobreza. A continuación, revisaremos le evolución de algunos indicadores de pobreza a través del tiempo para el departamento:

Tabla 2: Evolución Indicadores de Pobreza para el Departamento de la Guajira en Colombia

AÑOS	PORCENTAJE		COEFICIENTE GINI
	POBREZA	POBREZA EXTREMA	
2010	46,9	14,2	0,523
2015	41	12,7	0,522
2017	46,9	15,1	0,524

Fuente: DANE

A partir de la Tabla 2 podemos ver que los niveles de pobreza extrema en el 2017 han tenido un aumento respecto al año 2010 del 0.9%, mientras que los indicadores de pobreza monetaria se han mantenido estables respecto a estos dos años. Algo que es preocupante es que se presente una tendencia creciente asociada a estos indicadores de pobreza para el departamento de la Guajira, lo que sobre todo es preocupante en los niveles de desigualdad asociados al Coeficiente de Gini, donde parece mostrar una tendencia creciente, de forma constante que de seguir manteniéndose se esperaría una población con una distribución del ingreso mucho más desigual, lo que continuaría deteriorando el tejido social al crear condiciones económicas globales más adversas para la región.

Es menester que según el Informe Socioeconómico para la guajira (2018) las políticas públicas que se han establecido para la región no han sido eficientes y por ende no se ha tenido el efecto deseado, principalmente relacionado con bajos niveles de ejecución para las instituciones territoriales. En términos de desempeño, La Guajira está ubicado por debajo del promedio nacional, lo que muestra una

dificultad en alcanzar las metas propuestas en la política pública, generando repercusiones en las dimensiones de cobertura propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, asociados a la garantía adecuada de salud, educación y agua potable. Por otra parte, el recaudo fiscal del departamento es de baja capacidad lo que lo estaría encaminando a ser dependiente del Sistema General de Participación para financiar su actividad gubernamental y de inversión pública.

A nivel económico, el departamento es dependiente de la industria minero-energética, específicamente en la explotación de recursos como el gas y el carbón, donde el carbón tiene una participación del 43% aproximadamente del PIB de la Región, esta dinámica económica centrada en la explotación de recursos minero-energéticos en el departamento, permite en cierta medida la pérdida de riqueza natural que puede ser captura menos que proporcionalmente por el Sistema General de Regalías, además que impide otras vías de desarrollo económico sostenibles para la región como el turismo y la generación de industrias manufactureras que podrían brindar un mayor equilibrio económico a la región, reducir los niveles de pobreza monetaria y pobreza extrema así como mejorar el recaudo fiscal por parte de las entidades territoriales que permitirían romper trampas de pobreza asociadas a deficiente acceso al agua potable, bajos niveles de educación, mala calidad ambiental que según el Observatorio de Ambiente y Salud Departamento de la Guajira (2018) La minería a cielo abierto, genera efectos ambientales como la emisión de partículas finas a la atmósfera que son respiradas por los habitantes del departamento, descargas de agua contaminadas con residuos de la actividad minera hacia fuentes naturales de agua, erosión y pérdida de la capa vegetal en zonas aledañas asociadas a la remoción de capa vegetal para la actividad minera.

Ahora dentro de otras características demográficas de la población tenemos que una razón de sexos de 95.98 según la Tabla 1, nos muestra una distribución relativamente igual entre hombres y mujeres en el departamento, de tal manera que esta presencia equitativa de género en poblaciones en edad de trabajar, permitirían generar un dinamismo económico en la región dada la introducción de otras actividades económicas que complementen la presencia de la industria minero-energética, sin embargo esta pequeña diferencia se ve reflejada en el índice de feminización de 124.18, donde para el año 2018 por cada 100 hombres mayores a 65 años hay 124.18 mujeres en este rango de edad.

La relación de dependencia mayor a 1 nos dice que existe una alta proporción de personas dependientes en la población respecto a la población en edad de trabajar, esto nos sugiere que para el nivel de dependencia senil 8.60, existe una población pequeña envejecida con mayor necesidad de atención médica para personas mayores y programas de jubilación, y para la población juvenil el índice de dependencia es de 57.66, lo que implica que existe una población más joven con mayor necesidad de servicios educativos. En este orden de ideas la población en edad de trabajar y población económicamente activa tiene un sostenimiento de las necesidades de la población dependiente mayoritariamente infantil para el departamento. Ahora finalmente con la población mayor a 60 años es de 7.33%, esto implica que la población envejecida mayor a 60 años es del 7%.

Gráfica 2: Pirámide Poblacional de la Guajira para la Población Urbana y Rural 2018:

Fuente: Elaboración Propia

A partir de la Gráfica 2, tenemos que la población urbana en el departamento tiene una base mucho más reducida que la pirámide poblacional para las áreas rurales, lo que implica que a

nivel urbano existe probablemente una tendencia a tener menor número de hijos, quizás al mejor acceso a servicios educativos y de salud sexual y reproductiva, las áreas urbanas parecen tener valles que indican la presencia de inmigración, posiblemente explicado por su frontera con Venezuela y la crisis económica del país por lo que este departamento puede ser un lugar de residencia temporal o permanente para inmigrantes venezolanos, por otra parte la pirámide urbana más rectangular o achatada en su parte media muestra una mayor esperanza de vida para personas de 10 a 44 años y finalmente podemos observar que en términos de mortalidad en la vejez, existe una menor mortalidad en la población urbana que en la población rural, probablemente por la facilidad de acceso a servicios públicos de mayor calidad en la infraestructura urbana, mientras que en la rural la población en vejez, tiene más dificultades para el acceso a agua potable, servicios de salud en términos de transporte así como la propia cultura asociada a los resguardos indígenas que es protegida por la constitución y que tiene libertad propia de ejercer sus leyes, creencias y prácticas culturales con apoyo del Estado, por ende el ejercicio de sus prácticos.

Finalmente podemos ver que en los distintos grupos etarios parece existir una mayor proporción de mujeres que hombres en promedio.

Municipio de Riohacha – La Guajira

Tabla 3: Indicadores Demográficos para el Municipio de Riohacha La Guajira Colombia 2018:

Indicadores Demográficos	Riohacha	
Indicadores Tamaño y Distribución		
Tamaño	177.573,00	
Porcentaje Población Urbana	68,38%	
Porcentaje población rural	31,62%	
Densidad población total	57,58	
Densidad población urbana	39,37	
Densidad población rural	18,21	
Indicadores Estructura		
Razón de Sexos	95,55	
Indice de feminización	124,34	
Relación de dependencia	60,74	
Relación de dependencia senil y juvenil	7,22	53,52
Indice de envejecimiento	13,48	
Indice de Sobreenvejecimiento	20,17	
Porcentaje de mayores de 60 años	7,05	

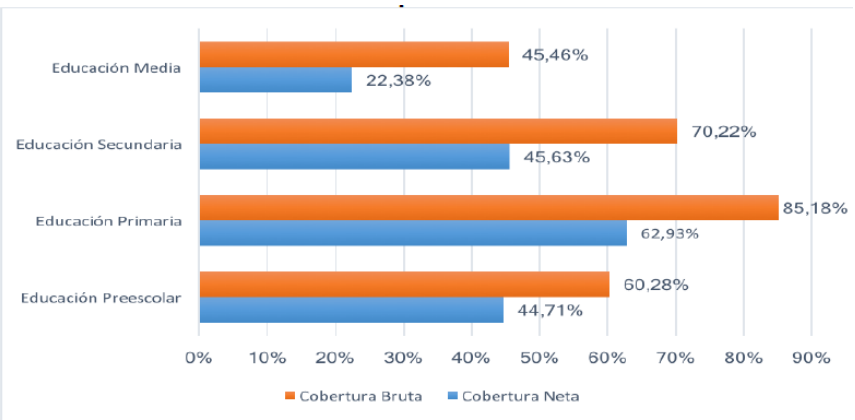
Fuente: Elaboración Propia

Riohacha, un municipio situado en la costa caribeña del departamento de La Guajira, destaca como la capital más septentrional de la región caribeña colombiana, así como de toda Colombia continental y Suramérica en su conjunto. Este municipio abarca aproximadamente una cuarta parte del territorio total del departamento, con una extensión que se extiende a lo largo de 491.383 hectáreas. De esta superficie, un 27% está reservado para zonas de resguardo indígena, mientras que otro 27% forma parte del Parque Nacional Natural Sierra de Santa Marta. Además, un pequeño porcentaje, equivalente al 0,9%, corresponde al Santuario de Flora y Fauna de los Flamencos.

Según el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha tenemos que su economía local se centra fuertemente en actividades de explotación ganadera, no exclusivamente en vacunos sino también en porcinos, equinos, asnos, y ovinos, por otra parte, la pesca artesanal es una actividad relevante. A su vez como la explotación forestal, de distintos tipos de madera provenientes de manglares, madera de cedro, caoba, dividivi etc. Así como la región, es importante recalcar que el municipio de Riohacha carece de industria manufacturera, sin embargo, su explotación no se centra en la industria de minero-energética como lo es el comportamiento global del departamento.

Ahora por otra parte, Riohacha continúa con la tendencia en términos de pobreza, explicadas anteriormente según el Informe Socioeconómico de la Guajira (2018). Los mayores valores de incidencia de pobreza monetaria a nivel municipal se presentaron en las ciudades de Quibdó con un nivel de incidencia de la pobreza de 17.70%, seguido de Riohacha con un nivel de 15.1%; situando al municipio como el segundo en incidencia de pobreza para el Departamento.

Gráfico 3: Cobertura Bruta y Neta de Educación para el Municipio de Riohacha en Colombia 2018:



Fuente: Terridata, Ministerio Nacional 2018

A partir del Gráfico 3 podemos ver que la cobertura neta, para la educación a nivel preescolar que usualmente inicia a los 5 años de edad es del 44.71%, la educación prima es fundamental para desarrollar las habilidades cognitivas básicas que debe tener un niño para un correcto desarrollo en su adolescencia, la tasa de cobertura neta para esta es del 62.93%, mientras que en educación media y secundaria las tasas netas de cobertura son del 45.63% y 22.38%. Es preocuparte ver las tasas de educación secundaria y media, pues de 45.63 de cada 100 niños en etapa de entrar a la educación secundaria no lo hacen, mientras que 22.38 de cada 100 jóvenes en etapa de entrar a la educación media no lo hacen, causando que estos bajos niveles de cobertura permitan la generación de trampas de pobreza, pues un bajo nivel educativo está asociado a bajos niveles de ingreso, y por ende sería un factor en la perpetuación intergeneracional de la pobreza.

Gráfico 4: Cobertura de Servicios Públicos La guajira, Riohacha y Nivel Nacional 2018

Información de Viviendas	Municipio/ Departamento	Cobertura de Servicios domiciliarios					
		Energía eléctrica	Acueducto	Alcantarillado	Gas**	Recolección basuras	Internet**
CNPV 2018	Colombia	96,3%	86,4%	76,6%	67,3%	81,6%	43,8%
	La Guajira	60,7%	46,6%	41,9%	40,4%	46,1%	10,8%
	Riohacha	81,5%	69,0%	55,2%	60,2%	67,7%	24,4%
CG 2005	Colombia	93,6%	83,4%	73,1%	40,4%	ND	ND
	La Guajira	62,0%	51,3%	38,3%	35,5%	ND	ND
	Riohacha	79,5%	69,4%	54,0%	52,7%	ND	ND

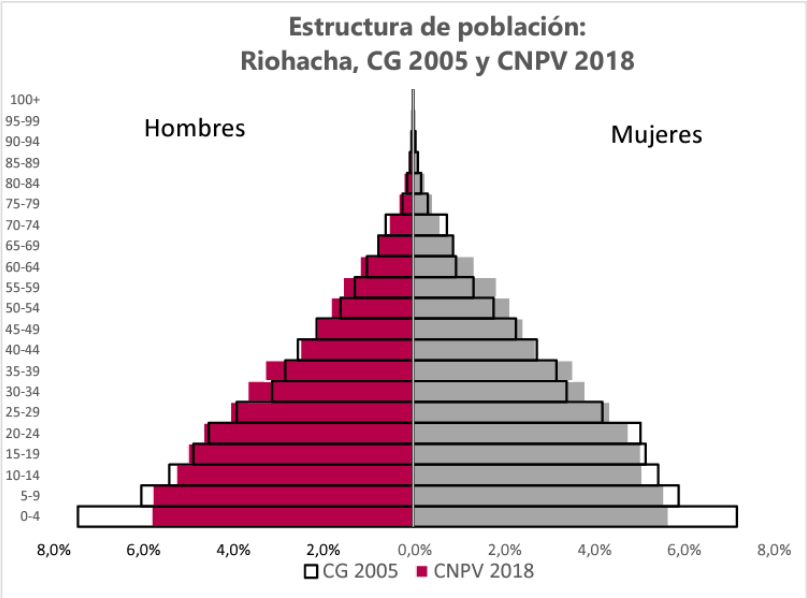
Fuente: DANE – Censo Personas 2018

A partir del **Gráfico 4**, podemos ver comparativamente el municipio de Riohacha en el año 2005 que no ha tenido cambios significativos respecto a la cobertura de servicios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado con respecto al año 2018, mostrando que las políticas

públicas asociadas a los entes territoriales han sido ineficientes en algunas dimensiones como esta, pues se esperaría que la evolución temporal y el cambio tecnológico que conlleva este facilitaran la eficiencia de la cobertura, sin embargo dentro de los servicios públicos tenemos que los que menor cobertura tienen son el alcantarillado con un 55.2% de cobertura y el servicio de internet con un 24.4% de cobertura. Esto puede causar resultados graves para el desarrollo de la población en términos de la brecha digital entre Colombia a nivel nacional y Riohacha a nivel municipal, por otra parte, la baja cobertura de servicio de alcantarillado genera riesgos para la salud lo cual tiene efectos adversos sobre la productividad de la población expuesta a esta y por ende sobre su ingreso laboral futuro.

Posterior a este análisis económico y ambiental de la zona, tenemos la siguiente distribución poblacional del municipio:

Gráfico 5: Pirámide Poblacional del Municipio de Riohacha 2005 – 2015 La Guajira Colombia:

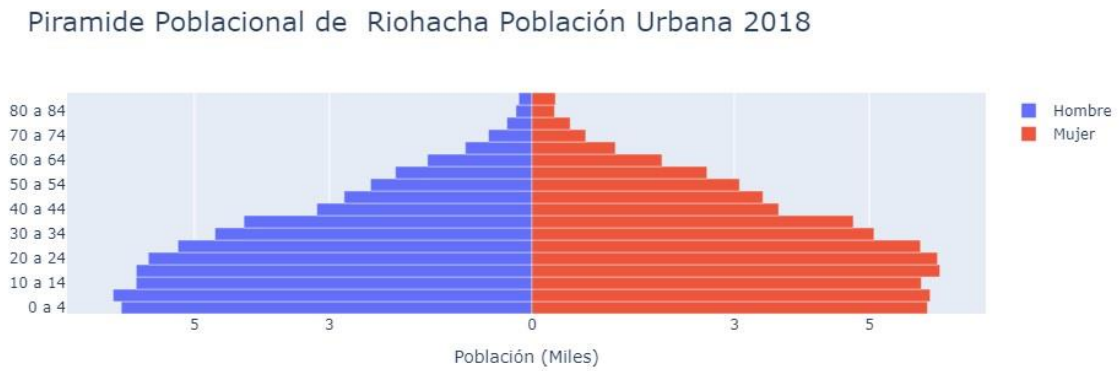


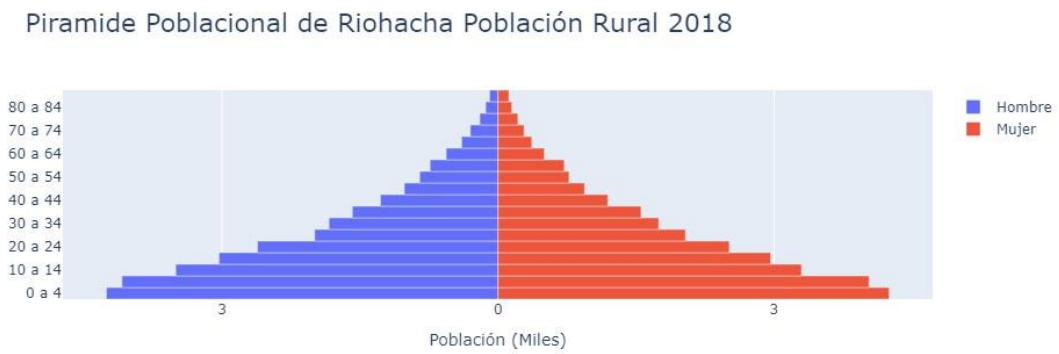
Fuente: DANE Censo Nacional de Población 2018 – Censo General 2005

A partir del **Gráfico 5**, tenemos que una base gruesa de la pirámide nos dice que existe en el municipio de Riohacha una alta natalidad y una alta mortalidad dada la parte afilada de la pirámide en su vértice superior, parece verse alta mortalidad o posible emigración en los grupos etarios de 30 a 34 años, quizá población que busca otros municipios o países con mejor calidad de vida, por otra parte vemos alta mortalidad en la población anciana, donde quizás

las condiciones estructurales y económicas que determinan la dinámica de vida del municipio así como la cobertura incompleta para los servicios públicos puedan generar las condiciones necesarias para una vejez con dificultades de acceso a la salud oportuna y preventiva que puedan permitir a las personas mayores una mayor y mejor calidad de vida en esa etapa. Ahora para el año 2018 vemos un estrechamiento de la base, lo que implica una caída en la natalidad y un crecimiento poblacional en los grupos etarios de 30 a 39 años, lo que puede surgir debido a la permanencia de la tendencia a la baja en la calidad a la región, esto implica alta mortalidad infantil y un vértice más estrecho en la punta respecto al año 2005 puede sugerir una menor esperanza de vida en la vejez, pero una mayor esperanza de vida en grupos etarios medios y relativamente altos es decir edades de 55 a 59 años. Finalmente, para ambos periodos no suele verse una diferenciación significativa en el comportamiento para los hombres y mujeres del municipio.

Gráfico 6: Pirámide Poblacional de Riohacha – La Guajira para población Urbana y Rural 2018:





Fuente: Elaboración Propia

Para la población urbana, tenemos una pirámide que parece ser estancada, esto quiere decir que las tasas de natalidad y mortalidad se empiezan a mantener constantes en el tiempo y no sufren cambios significativos a través de este. Lo que nos llevaría a pensar primero en una alta esperanza de vida en personas en calidad de adultos mayores por otra parte en el Gráfico 6, podemos ver que, para la población rural, existe una alta tasa de natalidad alta y una mortalidad alta en la población de adultos mayores, lo que caracteriza las distribuciones poblaciones en América Latina.

Ahora algunas estadísticas demográficas podemos ver en la Tabla 3, que el municipio cuenta 177.573 personas, donde el 68.38% de la población vive en zonas urbanas, mientras que el 31.62% vive en zonas rurales. Dado un territorio de 3084 km cuadrados, existen 57.58 personas por kilómetro cuadrado, dentro de esta distribución 39.37 personas de tipo población rural hay por kilómetro cuadrado, mientras que 18.21 personas de tipo población rural hay por kilómetro cuadrado. La razón de sexos de 95.55 muestra un número mayor de mujeres que de hombres, sin embargo, no parece ser una diferencia significativa, donde tenemos en el índice de feminización que por cada 100 hombres mayores a 63 años hay 124 mujeres en este rango de edad.

Por otra parte, para la dependencia económica, una relación de dependencia de 60 desagregada en 7.22 senil y 53.52 infantil, nos dice que existe una alta densidad poblacional económicamente dependiente siendo la mayor parte de esta población infantil, el índice de envejecimiento es relativamente bajo lo que nos dice es que la población para el municipio de Riohacha es en mayor proporción joven y en ese orden de ideas tenemos que el 7.05% de la población total es mayor a 60 años.

Análisis de la Mortalidad

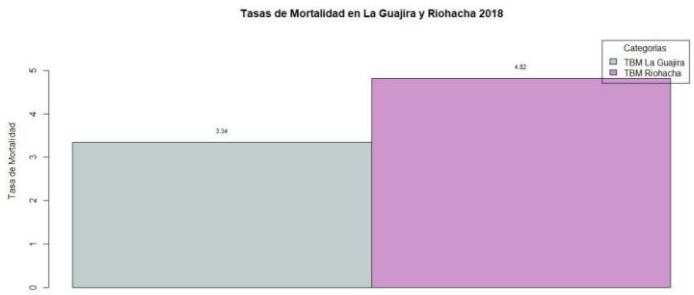
Tabla 4: Tasa Bruta de Mortalidad en la Guajira y Riohacha 2005, 2018:

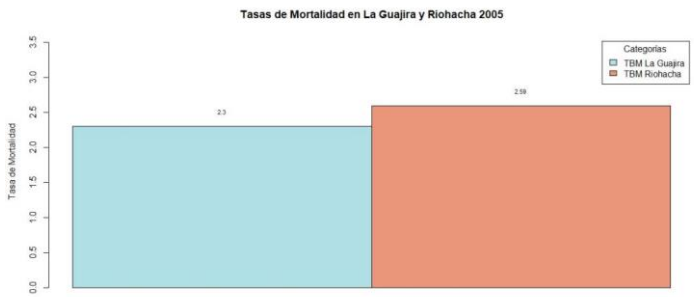
TBM La Guajira	3,34
TBM Riohacha	4,82
TBMH La Guajira	3,82
TBMM La Guajira	2,88
TBMH Riohacha	5,74
TBMM Riohacha	3,94

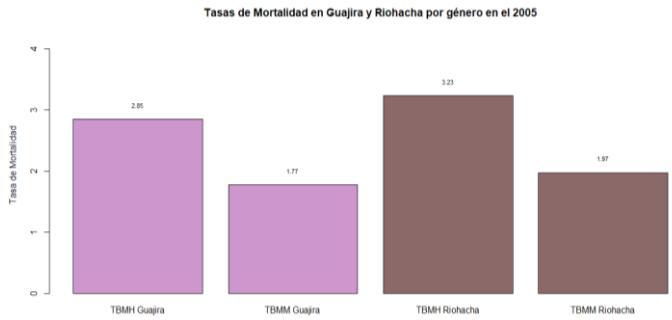
TBM La Guajira	2,30
TBM Riohacha	2,59
TBMH Guajira	2,85
TBMM Guajira	1,77
TBMH Riohacha	3,23
TBMM Riohacha	1,97

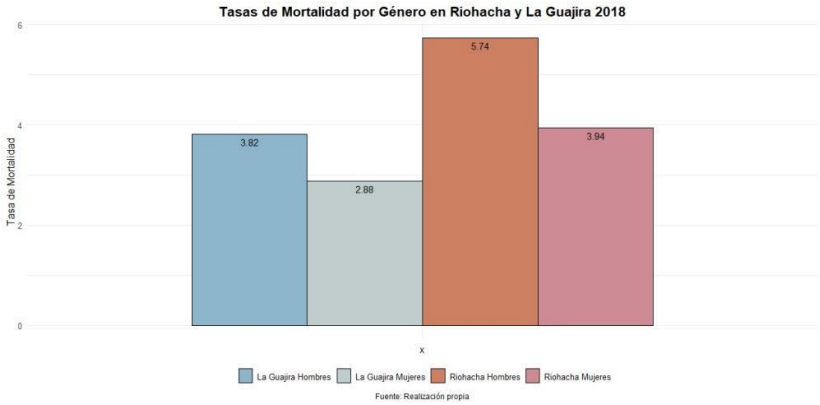
Fuente: Elaboración Propia a partir de Datos del Censo 2005-2018 DANE

Gráfico 7: Tasa de Mortalidad Bruta en la Guajira y Riohacha por sexo 2005 -2018









A partir de la **Tabla 4** y **Gráfico 7** podemos observar que para la Guajira, por cada 1000 personas fallecen 3.34 para 2005, mientras que para 2018 fallecen 2.30 personas por cada 1000, lo que representa a nivel global una reducción del 1.04 en la defunción bruta para el departamento, cuando desagregamos por sexo para la Guajira tenemos para el año 2005 que por cada 1000 hombres fallecen 3.82, mientras que para el año 2018 por cada 1000 hombres fallecen 2.84, representando una reducción de 0.98, para el caso de las mujeres del año 2005 al 2018 se ve reducida su mortalidad bruta en 1.11 puntos. A nivel municipal para Riohacha para el año 2005, tenemos que por cada 1000 personas fallecen 4.82 llegando a que por cada 1000 personas fallecen solamente 2.58 en 2018 y desagregado por sexo, por cada 1000 hombres fallecen 5.74 y para el 2018 por cada 1000 hombres fallecen 2.84 y en el caso de mujeres entre el año 2005 y 2018 la mortalidad se redujo a la mitad.

Para el caso del 2005 el comportamiento bruto de la mortalidad en la guajira estuvo por debajo del promedio de la mortalidad en Colombia que fue del 4.4 por cada mil habitantes y para el año 2018 la tasa bruta de mortalidad en la guajira estuvo por debajo del promedio nacional la cuál fue de 5.31 defunciones por mil habitantes. Sin embargo según Bonet J, Wilfried L (2017) exploran los distintos elementos coyunturales y estructurales que presenta la región y que inciden principalmente en la mortalidad infantil, donde la presencia de una alta dispersión geográfica y que gran parte del departamento contiene la zona desértica más grande del país dificultando la generación de sostenibilidad alimentaria en el territorio, lo que obviando cuestiones asociadas a la corrupción en el manejo de recursos públicos y la presencia de grupos delincuenciales en las disputas de las rutas de narcotráfico por su condición geográfica estratégica , dificultan el acceso y recolección de información completa para las entidades estadísticas, en este caso podría explicar las tasas de mortalidad brutas por debajo del promedio nacional para el periodo de 2005 y 2018.

Históricamente la Guajira ha tenido dificultades para su sostenibilidad alimentaria y sanitaria, personas como Gustaf Bolinder realizó una filmación videográfica de niños en estado de desnutrición en el año 1920 y Michel Perrin en el año 1973 en su documental llamado "El camino de los indios muertos", muestra la hambruna como un ser mitológico de la cultura wayuu que persigue sus huellas generándoles tormento perpetuo.

Dentro de sus características particulares algunos autores sugieren las principales condiciones geográficas que componen el territorio, Meisel (2007) Describe la presencia de una baja precipitación y humedad, así como una luz solar intensa, por otra parte el difícil los altos niveles de corrupción y el abandono estatal han sido elementos históricos en el departamento, donde en el año 2017 el estado intervino directamente en las finanzas del departamento y en la prestación de servicios públicos como educación, agua potable, alcantarillado y salud a través de las resoluciones 0459, 0460 y 0461 del 21 de febrero de 2017 donde la intervención representó un valor por encima de los 700 mil millones de pesos que serán manejados por las autoridades sectoriales.

Arias I. et al (2011) Señalan las dinámicas comerciales de la guajira con Venezuela y su frontera con el Caribe, que surgen a partir de la cultura de la ilegalidad donde esta proviene de la ausencia de instituciones fuertes en el departamento que brinden bienes y servicios públicos consistentes y de calidad que permitan a las personas tener un nivel de vida adecuado, las actividades ilegales como el contrabando inicialmente en el siglo XIX de Tabaco, Telas y Licor en las fronteras permitían el sustento económico de la región y posteriormente en la bonanza marimbera de finales de los sesentas y mediados de los 70, generó un cambio en la estructura del contrabando, donde estos contaban con grupos armados para su protección y eran actividades legítimas dentro de la comunidad de la guajira, el contrabando paso de ser de licores, tabaco y marihuana a cocaína y consecuencialmente al narcotráfico y microtráfico.

Tabla 5: Tasa Específica de Mortalidad por quinquenios en La Guajira Riohacha 2005:

	Rangos de edad	Total Defunciones	TEM
La Guajira Riohacha	0 años	30	53,31
	1 a 4 años	59	23,74
	5 a 9 años	8	3,95
	10 a 14 años	12	6,51
	15 a 19 años	18	10,55
	20 a 24 años	25	15,34
	25 a 29 años	20	14,50
	30 a 34 años	16	14,40
	35 a 39 años	25	24,45
	40 a 44 años	20	22,18
	45 a 49 años	13	17,31
	50 a 54 años	30	51,88
	55 a 59 años	33	73,83
	60 a 64 años	20	59,52
	65 a 69 años	31	110,09
	70 a 74 años	23	99,48
	75 a 79 años	25	259,61
	80 a 84 años	19	361,90
	85 a 89 años	13	433,33
	90 a 94 años	15	980,39
	95 a 99 años	10	2083,33
	100 a 104 años	2	1333,33
	110 a 114 años	1	1111,11

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 6: Tasas Específicas de Mortalidad en La Guajira 2005:

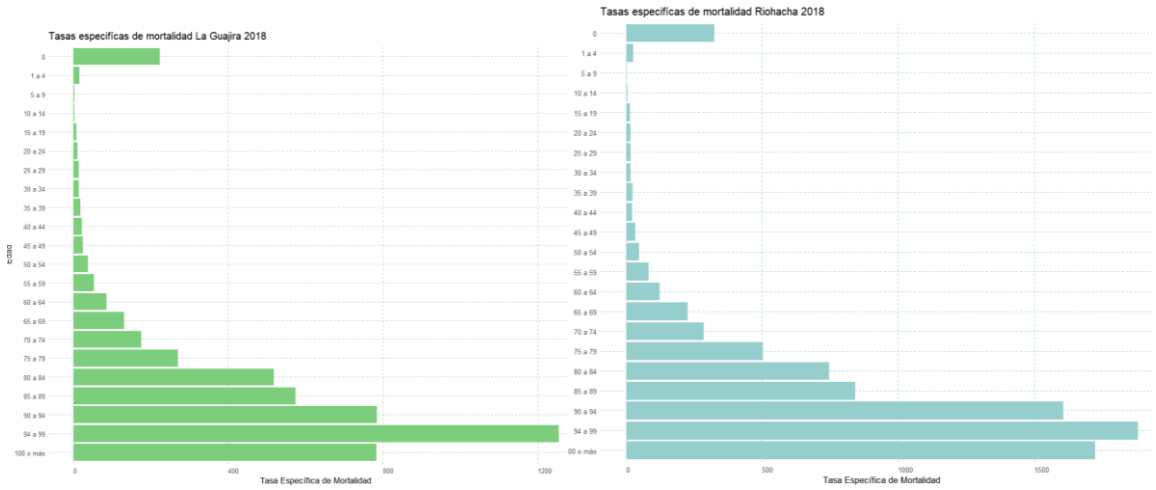
	Rangos de edad	Total Defunciones	TEM
La Guajira Total	0 años	91	36,52
	1 a 4 años	199	18,18
	5 a 9 años	29	3,40
	10 a 14 años	35	4,67
	15 a 19 años	54	8,58
	20 a 24 años	86	15,21
	25 a 29 años	88	18,04
	30 a 34 años	71	17,65
	35 a 39 años	88	23,41
	40 a 44 años	70	21,65
	45 a 49 años	56	20,45
	50 a 54 años	80	40,05
	55 a 59 años	87	51,96
	60 a 64 años	68	54,78
	65 a 69 años	80	72,59
	70 a 74 años	85	100,75
	75 a 79 años	85	170,99
	80 a 84 años	78	279,27
	85 a 89 años	74	453,99
	90 a 94 años	55	833,33
	95 a 99 años	33	1217,71
	años	4	512,82
	años	2	1250,00

En las Tablas 5 y 6 podemos ver la mortalidad en menores de un año, que corresponden a 36.52 por cada mil nacidos vivos para la Guajira, mientras que para Riohacha 53.31 defunciones de menores a un año por cada mil nacidos vivos. Estas cifras son altas a comparación de la mortalidad infantil en Colombia, que para el año 2005 fueron de 20

defunciones por cada mil nacidos vivos aproximadamente según las cifras de mortalidad de la Encuesta Nacional de Salud desarrollada por Pro familia, esto muestra que la guajira tiene altas condiciones de mortalidad y condiciones de salud pobres que inciden en la mortalidad infantil, para la mortalidad de la niñez tenemos que para el año 2005 la guajira tiene un valor de 23.74 defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos para Riohacha y 18.18 defunciones de menores de cinco años por cada mil nacidos vivos para la guajira, comparativamente con las defunciones de menores de cinco años a nivel nacional para este año fue de 18 defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos. Para este caso la mortalidad de la niñez sigue encontrándose por arriba del promedio nacional.

Por otra parte las mortalidades a nivel agregado sugieren el comportamiento de una pirámide con base ancha y angosta en edades avanzadas, sugiriendo que las condiciones estructurales y coyunturales de la guajira tienen efectos en la esperanza de vida de las personas de 50 años hacia arriba, las cuáles son más propensas a enfermar o sufrir complicaciones y a perder su condición física para el desarrollo de actividades económicas, especialmente vemos una sobre mortalidad en personas de 95 a 99 años de edad.

Gráfico 8: Tasas Específicas de Mortalidad La Guajira y Riohacha 2018



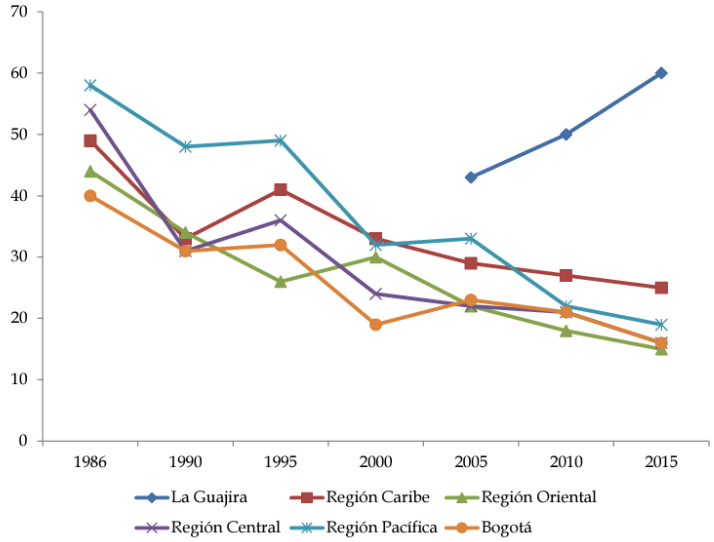
Fuente: Elaboración Propia

En el Gráfico 8 y Gráfico 9, podemos ver el comportamiento de la mortalidad específica para la Guajira y Riohacha en el año 2018. Con 224.36 defunciones de niños menores a un año de edad por cada diez mil nacidos vivos, y 324.94 defunciones de niños menores a un año de edad por cada diez mil nacidos vivos, a nivel nacional la mortalidad infantil es de 111.5

defunciones por cada diez mil nacidos vivos, lo que representa que para la guajira y Riohacha sus tasas de mortalidad infantil están por encima de la media, lo que nos dice que existe una alta mortalidad y un bajo nivel de acceso a servicios de salud de calidad, para la mortalidad de la niñez. Riohacha en el año 2018 tiene una tasa de 26.69 defunciones de niños menores a 5 años por cada diez mil, mientras que la Guajira tiene una tasa de mortalidad de la niñez de 16.57 defunciones de niños menores a 5 años por cada diez mil 136.6, para este caso la mortalidad en la niñez está por debajo del promedio nacional, lo que nos lleva a pensar en un posible subregistro de las defunciones nuevamente explicadas por las condiciones geográficas del territorio y sociales, aunadas a una gran dispersión de sus habitantes.

Finalmente podemos ver para la Guajira y Riohacha que los 70 años la mortalidad se acelera, viéndose especialmente alta en edades de 94 a 99 años.

Gráfico 10: Mortalidad en menores de cinco años por regiones entre 1986 y 2015



Fuente: Banco de la República

A partir del Gráfico 10, podemos observar la evolución en el tiempo de la mortalidad de menores de cinco años a nivel regional en Colombia desde 1986 hasta 2015, han venido decreciendo a lo largo del tiempo para las distintas regiones, para el caso de la Guajira que se cuenta con información del DANE desde 2005, 2010 y 2015 a su vez también de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, se evidencia la prevalencia en la mortalidad de la niñez, en primera medida se encuentra por encima de los otros niveles regionales y muestra una tendencia creciente, donde una de las principales causas en la infancia es la desnutrición,

autores como Ruiz (2016) realizó un estudio asociado a la mortalidad por desnutrición para niños menores de un año, a través del uso de las estadísticas vitales de 2002 y 2013 donde encontró que la mortalidad por desnutrición en la guajira está dos veces por encima que la del promedio nacional, centrándose en lugares como Maicao y Riohacha, el cuál en nuestro caso presenta una mortalidad infantil y de la niñez por encima del promedio departamental, se atribuye esta mortalidad a factores estructurales y coyunturales como la actividad económica minera (Carbón) de la guajira, la ausencia de agua por los ciclos fluviales y la falta de sostenibilidad alimentaria dado un suelo altamente alcalino, donde según el IDEAM (2012) el 5% del suelo de la Guajira tiene posibilidad de uso agrícola y el 2% de uso pecuario, a nivel nacional estos indicadores reflejan una capacidad del 19% y 13% respectivamente, lo que muestra una dificultad en la sostenibilidad alimentaria del departamento, a nivel agregado poseen un 11% de capacidad de generación de alimento en base a la actividad agropecuaria y agrícola.

Principales Causas de Muerte en la Guajira y Riohacha para el año 2005:

LA GUAJIRA		TOTAL	
TOTAL	TOTAL	Hombres	Mujeres
109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3,84%	3,15%	4,87%
303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	10,76%	9,85%	12,11%
307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	5,97%	4,73%	7,83%
404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	4,49%	3,84%	5,47%
501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	4,20%	4,43%	3,84%
512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	19,03%	29,06%	3,99%
601 DIABETES MELLITUS	2,48%	1,87%	3,40%
602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	2,48%	3,05%	1,62%
615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	2,96%	3,15%	2,66%
	100,00%	100,00%	100,00%

RIOHACHA		TOTAL	
	TOTAL	Hombres	Mujeres
109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	4,46%	3,62%	5,53%
303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	6,09%	5,07%	7,37%
307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	7,51%	5,07%	10,60%
404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	7,30%	5,80%	9,22%
405 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	3,04%	3,26%	2,76%
501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	5,88%	6,88%	4,61%
512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	18,66%	31,88%	1,84%
611 OTRAS ENF. SISTEMA DISGESTIVO	2,84%	2,90%	2,76%
615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	2,84%	3,26%	2,30%
	100,00%	100,00%	100,00%

Para el caso de la Guajira en el año 2005 tenemos que las principales causas de muerte en sus habitantes son la aparición de tumores malignos con un 19% de mortalidad, seguido de enfermedades e infecciones en el periodo perinatal con un 10.76%, la cual comprende

trastornos hemorrágicos de la madre o el feto, trastornos respiratorios o cardíacos, trastornos hemorrágicos o hematológicos del feto e infecciones específicas, la desnutrición con un 5.97% de la mortalidad seguido de enfermedades cardíacas e hipertensivas con un 4.49% y 4.20% respectivamente. Las principales causas de muerte en la Guajira pueden asociarse a las condiciones de vida, pues algunas de estas enfermedades son previsibles e incluso tratables de forma exitosa en condiciones normales, sin embargo las condiciones adversas de la región que promueven épocas de hambruna, ausencia de agua y la baja cobertura y calidad en los servicios de salud inciden en la detección temprana y tratamiento de algunas de estas enfermedades, a nivel nacional para el año 2005 la principal causa de muerte según la Secretaría de Salud son las enfermedades isquémicas del corazón y las cerebro vasculares, que no se asocian a las principales causas en la Guajira como departamento.

A nivel de Riohacha las principales causas son las agresiones y homicidios, seguido de enfermedades cerebro vasculares, trastornos específicos del periodo perinatal, enfermedades isquémicas del corazón, accidentes en transporte terrestre, infecciones respiratorias agudas y sepsis bacteriana del recién nacido, estas principales condiciones como la sepsis son elementos de salubridad que afectan a la región, pues son más probables de presentarse en hospitales con deficiencias en su asepsia o condiciones de higiene y control de transmisión de enfermedades intrahospitalarias, por otra parte la principal causa de muerte en Riohacha la violencia según Arias I, et al (2011) se asocia a la presencia de grupos paramilitares, las FARC, el ELN y la presencia de las bandas criminales BACRIM, que se disputan las zonas territoriales y las rutas de comercio del narcotráfico y microtráfico.

Principales Causas de Muerte en la Guajira y Riohacha para el año 2018:

Riohacha		Total		
		TOTAL	Hombre	Mujere
TOTAL	TOTAL	856	498	358
	108 Infecciones respiratorias agudas	7,13%	5,82%	8,94%
	303 Enfermedades isquémicas del corazón	9,23%	8,23%	10,61%
	307 Enfermedades cerebrovasculares	5,37%	4,22%	6,98%
	404 Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	3,39%	3,82%	2,79%
	501 Accidentes de transporte terrestre	3,27%	4,62%	1,40%
	512 Agresiones (homicidios)	6,54%	10,44%	1,12%
	602 Deficiencias nutricionales y anemias	3,39%	4,22%	2,23%
	613 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3,62%	3,82%	3,35%
	700 Signos, síntomas y afecciones mal definidas	4,44%	4,22%	4,75%

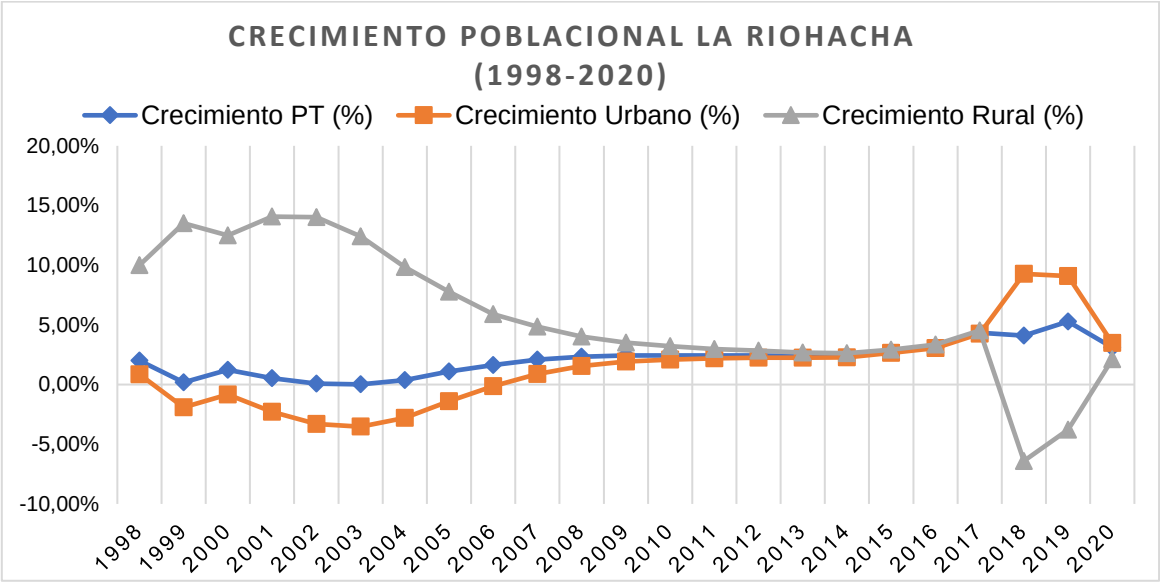
La guajira		Total		
		TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL	TOTAL	2.759	1.546	1.213
	108 Infecciones respiratorias agudas	6,78%	6,40%	7,25%
	303 Enfermedades isquémicas del corazón	8,88%	8,28%	9,65%
	307 Enfermedades cerebrovasculares	5,40%	4,72%	6,27%
	404 Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	3,70%	3,69%	3,71%
	501 Accidentes de transporte terrestre	4,64%	6,60%	2,14%
	511 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	1,23%	1,81%	0,49%
	601 Diabetes mellitus	2,72%	2,39%	3,13%
	610 Enfermedades del sistema urinario	3,08%	2,65%	3,63%
	612 Embarazo, parto y puerperio	0,91%	0,00%	2,06%
	613 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,57%	2,33%	2,89%
	614 Resto de las enfermedades	2,46%	2,13%	2,89%
	700 Signos, síntomas y afecciones mal definidas	3,19%	3,30%	3,05%

Para el caso de la Guajira en el año 2018 tenemos que las principales causas de muerte en sus habitantes son la aparición de infecciones respiratorias agudas con un 6,78% de participación en las muertes totales, luego tenemos las enfermedades isquémicas del corazón con un 8,88% de participación, seguida de las enfermedades cerebrovasculares en donde pueden ser causadas por varios factores como el exceso de tabaquismo entre más componentes, por otra parte se tienen los trastornos respiratorios del período perinatal que están relacionadas con problemas durante el parto, prematuridad o exposición a factores nocivos durante el embarazo, seguido de los accidentes de transporte terrestre que pueden llegar a tener lesiones resultantes de accidentes automovilístico que llegan a ser causadas por distracciones, velocidad excesiva, condiciones de carretera, etc, el siguiente son las lesiones (Suicidios) su causa principal puede llegar a ser compleja y multifactorial, con factores como problemas de salud mental, experiencias traumáticas y falta de apoyo social, otra causa es la diabetes que resulta ser la incapacidad del cuerpo para regular los niveles de azúcar en la sangre, luego tenemos enfermedades en el sistema urinario que pueden ser causadas por infecciones, el siguiente son embarazos, partos y puerperio que son complicaciones relacionadas con el parto o embarazo o por hasta más factores, otra causa son las malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas que ocurren debido a problemas genéticos, con el resto de las enfermedades son variedad de condiciones médicas, y finalizando las principales causas se

tiene los signos, síntomas y afecciones mal definidas que se pueden abarcar una variedad de condiciones que pueden no haber sido diagnosticadas específicamente.

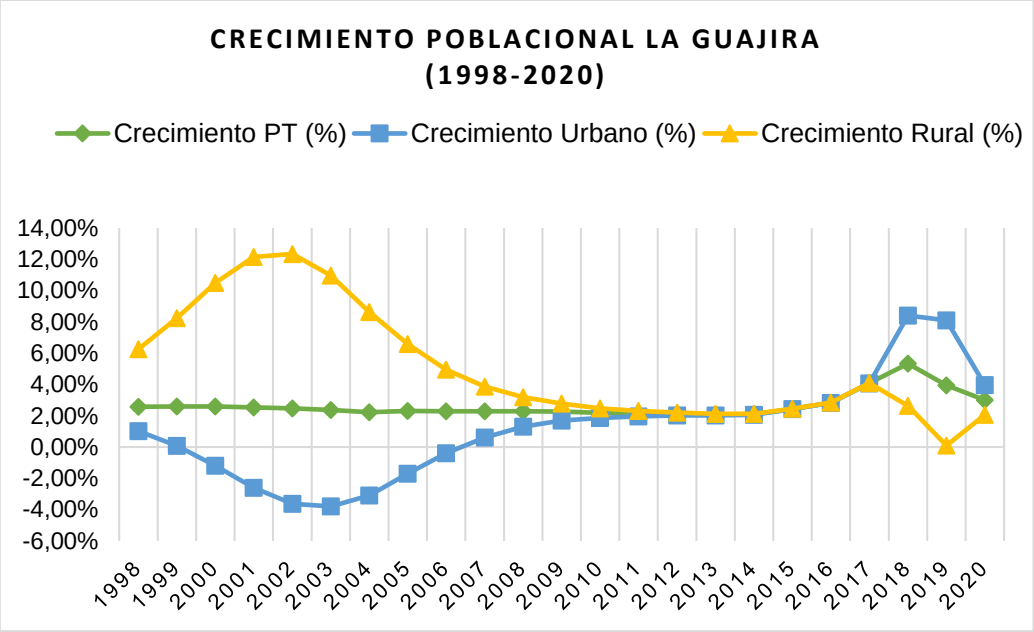
A nivel de Riohacha, las principales causas de enfermedad, que incluyen infecciones respiratorias agudas, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, trastornos respiratorios específicos del período perinatal, accidentes de transporte terrestre y agresiones (homicidios), reflejan una compleja intersección de factores de salud pública y sociales. Estas categorías abarcan desde problemas de salud infecciosa hasta condiciones crónicas y eventos traumáticos, evidenciando la necesidad de estrategias de intervención y prevención integrales. Para abordar eficazmente estas cuestiones de salud pública, se requiere una colaboración coordinada entre el sector de la salud, las autoridades locales, y otros actores sociales, con el objetivo de implementar medidas que aborden tanto los determinantes de la salud como las condiciones específicas que contribuyen a la carga de enfermedades en la comunidad.

Gráfico 11: Crecimiento Poblacional Riohacha 1998 – 2020



Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 12: Crecimiento Poblacional La Guajira 1998 - 2020



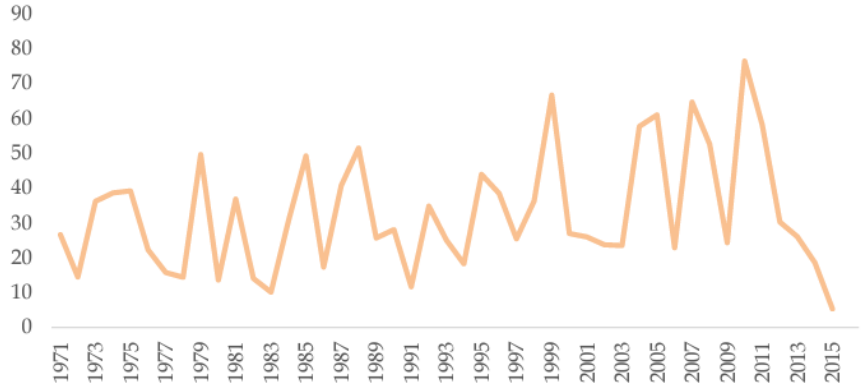
Fuente: Elaboración propia

A partir de la **Gráfica 11** podemos ver que la Riohacha en 1998 era predominantemente rural, con altos niveles de crecimiento en su población rural asociado a 10%, parece mostrar una tendencia decreciente desde el año 2001, desacelerándose a niveles de crecimiento del 3% anual en la población rural, esto puede explicarse por la dificultad en la sostenibilidad alimentaria especialmente en las zonas rurales y de la alta guajira, donde se encuentra la zona desértica más extensa, el comportamiento de la Guajira en el **Gráfico 12** es relativamente similar al de Riohacha en términos la movilidad en su población rural y urbana. A partir del **Gráfico 13**, podemos ver que desde 1999 la precipitación de lluvias en el departamento empieza a caer de forma acelerada casi empezándose a recuperar lentamente en el 2003, esto asociado a la baja capacidad agrícola natural que tiene el terreno, probablemente haya incidido sobre la movilidad de comunidades rurales hacia las zonas urbanas, por otra parte la actividad económica principal la cuál es la extracción de carbón, minería y gas han venido generando desplazamientos de comunidades, principalmente de comunidades wayuu que representan el 60% de la población indígena, por otra parte el crecimiento urbano se da de forma paralela respecto a la reducción del crecimiento rural, lo que nos muestra que ha venido generándose una transición de las comunidades rurales hacia las urbanas, quizás por motivos económicos y de sostenibilidad y seguridad.

Desde mediados de 2017 la población rural ha decrecido aceleradamente mientras que la población urbana creció de forma inversa y proporcional a esta.

A nivel general del crecimiento poblacional desde 2016 empieza a tener un incremento en sus niveles de crecimiento, esto puede ser explicado por la recepción de migración de ciudadanos venezolanos, siendo la guajira el mayor receptor de emigrantes por su condición de frontera ante el declive de la situación económica venezolana.

Gráfico 13: Precipitación Anual en la Guajira desde 1972



Fuente: elaboración propia con cifras provistas por el IDEAM. Nota: algunos de los valores de precipitación son estimados por el IDEAM usando otros métodos o se encuentran incompletos por razones no especificadas.

Gráfico 14: Crecimiento Migratorio Neto en Guajira 1998 - 2020

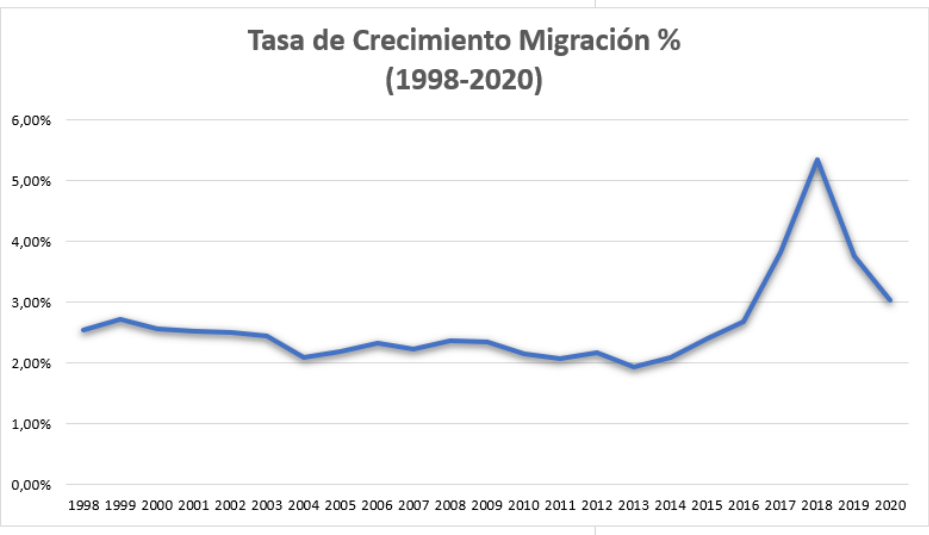
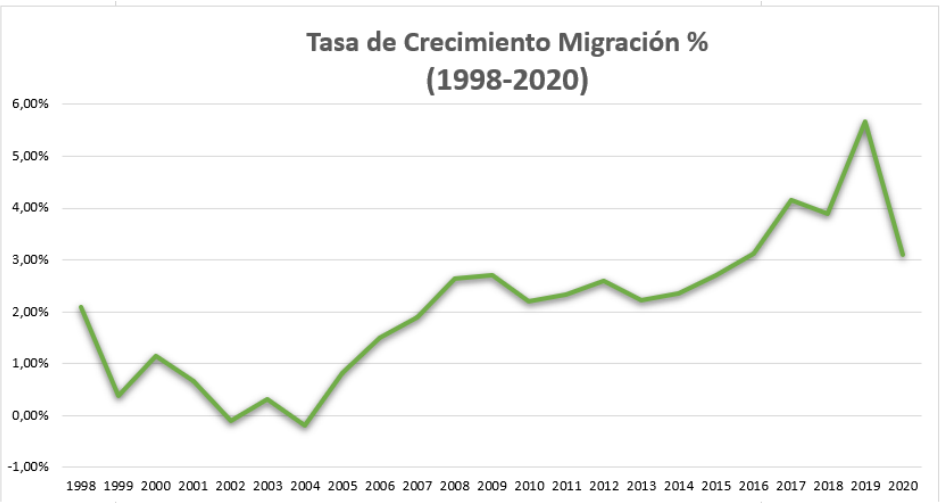


Gráfico 15: Tasa de Crecimiento Migración Neta en Riohacha 1998 - 2020



Fuente: Elaboración Propia

La serie de datos sobre la tasa de crecimiento de migración neta en Riohacha-La Guajira ofrece un fascinante vistazo a las dinámicas demográficas a lo largo del tiempo. En este conjunto, observamos una variabilidad anual que sugiere fluctuaciones en la llegada y salida de personas en la región. Los años con tasas más elevadas, como el impresionante 5.35%, indican momentos de un crecimiento poblacional sustancial impulsado por un flujo neto positivo de migración. Este fenómeno podría reflejar la atracción de la región debido a factores como oportunidades económicas, calidad de vida, o incluso eventos específicos que la hicieron especialmente atractiva en esos periodos. Por otro lado, los años con tasas más bajas, como el 1.94%, señalan períodos de menor impacto migratorio neto, donde la región pudo experimentar una estabilidad relativa en términos de llegada y salida de personas. La interpretación de estos datos es como desentrañar la narrativa cambiante de Riohacha-La Guajira, donde las cifras nos invitan a explorar los momentos de crecimiento dinámico y aquellos de transiciones más moderadas, proporcionando pistas valiosas sobre los factores que influyen en las decisiones migratorias y su influencia en la evolución demográfica de la región.

Gráfico 16: Defunciones en Riohacha 1998 a 2021 por tipo de Población

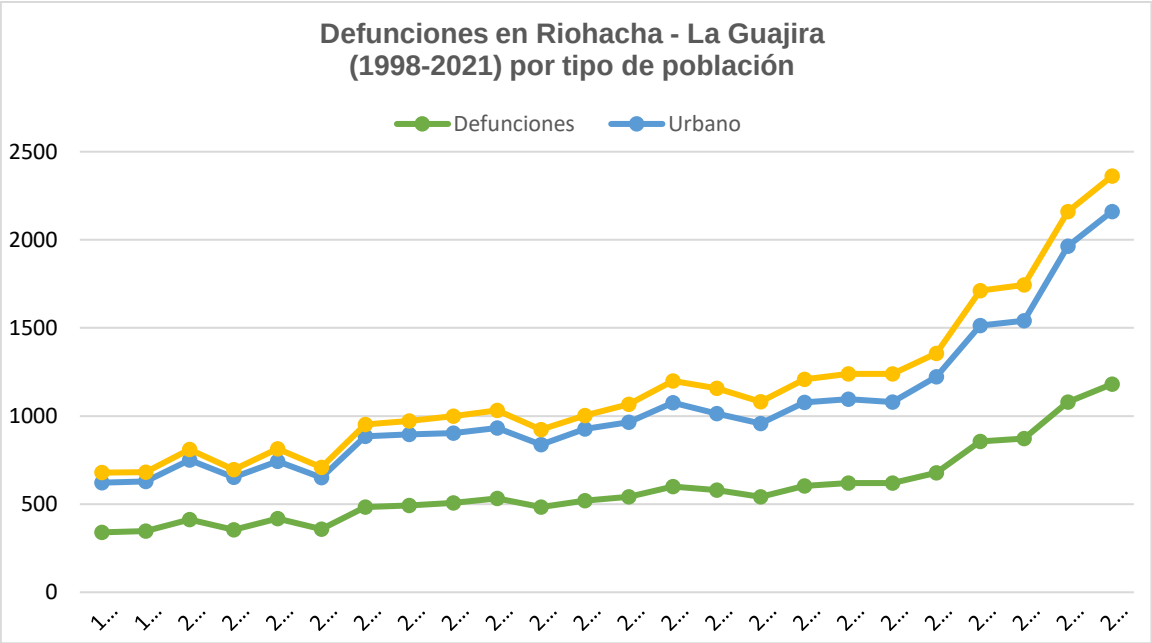
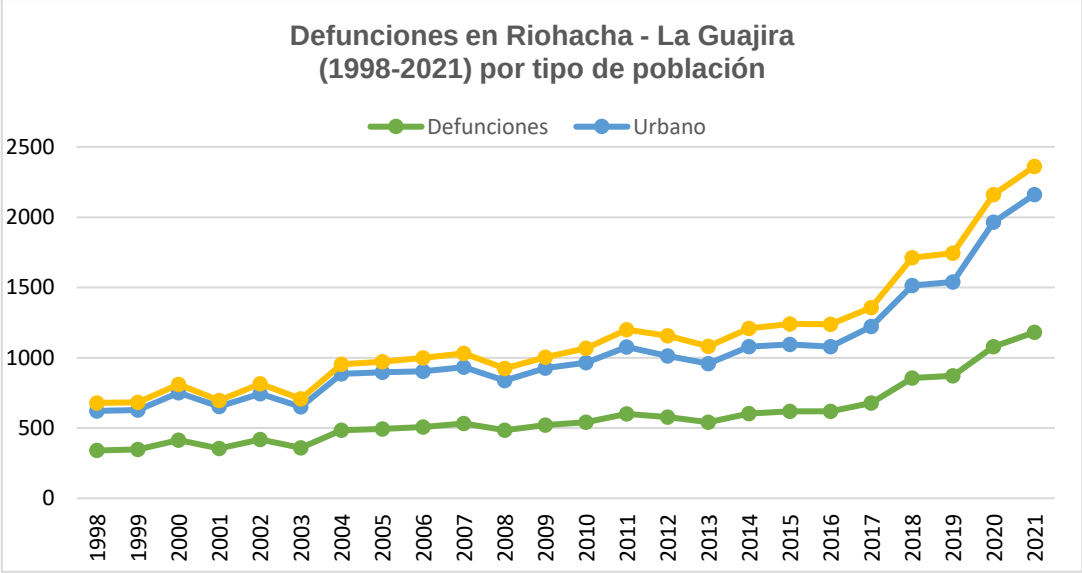


Gráfico 17: Defunciones en Riohacha 1998 a 2021 por tipo de Población



Fuente: Elaboración Propia

Podemos ver en el **Gráfico 16** y **Gráfico 17** que las defunciones en Riohacha han venido presentado una tendencia creciente, tanto en la población rural como en la urbana, siendo significativamente mayor la mortalidad rural, que podrían asociarse a algunas cuestiones en las comunidades rurales el acceso a servicios y bienes públicos de calidad es mucho más limitado, al igual que el de atención médica, la sostenibilidad alimentaria en las áreas rurales

es más crítica y la presencia de grupos armados de distinto tipo inciden la seguridad, por otra parte el aislamiento por parte del Estado permite la prevalencia de estas condiciones coyunturales.

Medidas de Política:

La importancia de las campañas de prevención en el contexto de la desnutrición es crucial, ya que la identificación temprana es el primer paso para reducir su prevalencia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece criterios para identificar la desnutrición en niños, considerando el retraso de peso para la talla, la presencia de edema bilateral y la circunferencia del brazo entre 6 y 59 meses. Aunque la circunferencia del brazo se recomienda por su facilidad y alta correlación con el riesgo de muerte, no siempre coincide con el indicador de peso para la talla. Por lo tanto, la OMS sugiere considerar ambos para una identificación precisa. Un niño se considera desnutrido agudo si presenta circunferencia del brazo inferior a 115 mm, edemas o un puntaje de peso para la talla más de tres desviaciones estándar por debajo del promedio. Además, la nutrición de las madres gestantes se ha identificado como un determinante crucial para la calidad de vida de los hijos, según hallazgos científicos presentados por Black et al. en 2013. Por ende, programas de alimentación que permitan a las madres gestantes y los niños tener el acceso a alimentos de forma permanente y oportuna.

Incrementar la cantidad de vías en el departamento para mejorar la conectividad de este a nivel interno y externo con el resto de Colombia, de tal manera se pueda incluir la Guajira dentro del circuito económico colombiano y eliminar su ausencia que está generando un rezago económico y social a comparación del resto del país.

Incrementar las condiciones de seguridad con el fin de desincentivar la perpetuación del conflicto armado y la lucha por las rutas de narcotráfico y microtráfico para los distintos grupos armados que hay en la guajira y que aportan al rezago en el desarrollo social.

Bibliografía

- Dane (2020). La información del Dane en la toma de decisiones de los departamentos. La Guajira. Tomado de: www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-desarrollo-territorial/050220-Info-Gobernacion-La-Guajira.pdf
- Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha (2022). Economía. Tomado de: https://www.riohacha-laguajira.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx#:~:text=%E2%80%8BUn%20rengl%C3%B3n%20importante%20de,se%20realiza%20en%20forma%20artesanal.
- Grupo de Investigación en Salud Pública. Observatorio de Ambiente y Salud. Departamento de la Guajira. Tomado de: www.car.gov.co/uploads/files/5cf973eb7af2f.pdf
- Cámara de Comercio de la Guajira (2018). Informe Socioeconómico de la Guajira: Estudio sobre el desempeño económico territorial 2018. Tomado de: www.camaraguajira.org/publicaciones/informes/informe-socio-economico-la-guajira-2018.pdf
- Bonet Morón J, Wilfried L (2017). La Mortalidad y Desnutrición Infantil en la Guajira. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional. Banco de la República. Cartagena
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., De Onis, M., ... y Uauy, R. (2013). "Maternal and child undernutrition and overweight in lowincome and middle-income countries". The lancet, Vol. 382, Núm. 9890.
- Acosta, K. (2015). "Nutrición y desarrollo en el Pacífico colombiano". Documento de trabajo sobre economía regional Núm. 221. Banco de la República.
- Acosta, K. y Romero, J. (2014). "Estimación indirecta de la tasa de mortalidad infantil en Colombia, 1964-2008". Economía y Región, Vol. 8, Núm. 2.
- Gaviria, A. y Hoyos, A. (2011). "Anemia and child education: The case of Colombia". Desarrollo y Sociedad, Núm. 68.
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (s. f.). "Valores medios multianuales de precipitación total en mm". Consultado el 17 de Abril de 2017. http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/LluviaAnualMensual_tabla.pdf